

TEMA 6.23 • INFECTOLOGÍA

Tuberculosis

PERFIL EUNACOM 1.05.1.023

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Tuberculosis (TBC)

Diagnóstico

- **Agente:** *Mycobacterium tuberculosis*.
- **Clínica:** Tos + expectoración (mucosa, purulenta o hemoptoica) + fiebre + baja de peso → síntomas > 2 semanas.
- **Imagen (Rx Tórax):** Compromiso apical, paquipleuritis, complejo primario (lesión pulmonar + adenopatía mediastínica).

TABLA 6.23.1: EXAMEN VS ROL

EXAMEN	ROL
Baciloscopías de expectoración (≥ 3)	Examen de elección (diagnóstico). S: 80%. Resultado inmediato.
Cultivo de Koch	Complemento. Aumenta sensibilidad pero demora 2-4 semanas .

Interpretación de baciloscopia: - Positiva → TBC confirmada + paciente **bacilífero** (contagioso) - Negativa → No descarta. Repetir. - < 50 neutrófilos/campo → Muestra mal tomada (saliva), repetir.

- **¿A quién pedir baciloscopías?**
- Sintomático respiratorio > 2 semanas
- Rx Tórax sugerente
- Contacto de paciente TB bacilífero

Tratamiento

Fase 1 — Diaria (50 dosis ≈ 2 meses)

RHZE: Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol

Fase 2 — Trisemanal (48 dosis ≈ 4 meses)

RH: Rifampicina + Isoniazida (×3/semana)

> Si RAM hepática: suspender **Pirazinamida** primero. > Si hay resistencia: derivar a tratamiento secundario (especialista).

Seguimiento: Baciloscopia mensual. Si (+) → solicitar cultivo para confirmar si vacilo vivo o muerto.

Casos Especiales

TABLA 6.23.2: SITUACIÓN VS DEFINICIÓN

SITUACIÓN	DEFINICIÓN	CONDUCTA
Fracaso	Cultivo (+) desde el 4º mes o baciloscopías que no negativizan hasta el 4º mes	Derivar a tratamiento secundario
Recaída	Tratamiento completo → alta → vuelve con baciloscopia (+)	Tratamiento primario de nuevo + estudio de contactos
Abandono	Suspensión > 4 semanas	Si < 1 mes: retomar donde quedó. Si ≥ 1 mes: reiniciar desde cero

Manejo de Contactos (convivientes del paciente bacilífero)

- **Todos los contactos:**

- Clínica respiratoria
- Rx Tórax
- Baciloscopia

Si tiene < 15 años → también PPD

¿Quiénes reciben profilaxis con Isoniazida?

- Contacto con PPD ≥ 10 mm (≥ 5 mm en VIH)
- < 15 años siempre
- VIH con PPD ≥ 5 mm
- **Duración:** 6 meses (9 meses en VIH).
- Si PPD (-) ahora → 3 meses de INH → repetir PPD → si sigue (-): suspender.

Recién Nacido de madre con TBC

- **No contraindica lactancia materna** (usar mascarilla en la madre) - RN queda con **Isoniazida profiláctica - BCG diferida** hasta completar profilaxis (vacuna viva, colisionaria con isoniazida)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente en tratamiento antituberculoso, al 5to mes de tratamiento la baciloscopia mensual sale positiva y el cultivo confirma bacilos vivos. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tuberculosis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico TBC: baciloscopías de elección (pedir 3-4, sensibilidad 80%). Cultivo complementario (demora 2-4 semanas). Baciloscopia con <50 neutrófilos = muestra inválida.
- Tratamiento fase diaria: 50 dosis RIPE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol). Fase trisemanal: 48 dosis RI (rifampicina, isoniazida). Lo que importa es el NÚMERO DE DOSIS.
- Fracaso = cultivo positivo desde 4to mes (causa: resistencia, derivar a tratamiento secundario). Recaída = post-tratamiento completo (caso nuevo, tratamiento primario). Abandono = suspensión >1 mes (reiniciar desde cero).
- Contactos de bacilífero: clínica + Rx + baciloscopia a todos. PPD en <15 años. Baciloscopia (+) = caso. Menor de 15 con Rx alterada = caso.
- Profilaxis: isoniazida si PPD >10 mm (>5 mm en VIH). Menores de 15 años SIEMPRE isoniazida (3 o 6 meses según PPD).
- Hepatitis por fármacos: suspender todo, derivar. Primero eliminar pirazinamida.
- RN de madre TBC: mantener lactancia, mascarilla, isoniazida al niño, BCG diferida post-tratamiento.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TUBERCULOSIS)

PREGUNTA 1

Paciente en tratamiento antituberculoso, al 5to mes de tratamiento la baciloscopía mensual sale positiva y el cultivo confirma bacilos vivos. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- A) Eliminación de bacilos muertos; continuar tratamiento
- B) Fracaso a tratamiento; derivar a tratamiento secundario
- C) Recaída; reiniciar tratamiento primario
- D) Abandono; reiniciar tratamiento desde cero
- E) Hepatotoxicidad; suspender pirazinamida

PREGUNTA 2

Niño de 8 años, contacto de su abuelo bacilífero. Baciloscopía negativa, radiografía normal, PPD de 12 mm. ¿Cuál es la conducta?

- A) Tratamiento antituberculoso completo (RIPE)
- B) Profilaxis con isoniazida por 6 meses
- C) Profilaxis con isoniazida por 3 meses y repetir PPD
- D) Solo observación clínica sin profilaxis
- E) Vacunación con BCG de refuerzo

PREGUNTA 3

Paciente completó tratamiento antituberculoso hace 8 meses con baciloscopías negativas al alta. Ahora consulta por tos productiva de 3 semanas y la baciloscopía sale positiva. ¿Cuál es la conducta?

- A) Derivar a tratamiento secundario por sospecha de resistencia
- B) Tratamiento primario completo y estudio de contactos
- C) Completar las dosis que le faltaron del tratamiento anterior
- D) Profilaxis con isoniazida por 6 meses
- E) Solo cultivo y antibiograma, esperar resultado antes de tratar

RESUMEN: TUBERCULOSIS

Esta clase aborda tuberculosis en detalle: diagnóstico, tratamiento, casos especiales y manejo de contactos. El agente es *Mycobacterium tuberculosis*. La clínica es tos y expectoración (puede ser hemoptoica) por al menos 2 semanas, con fiebre y baja de peso. El diagnóstico se basa en radiografía de tórax (afectación apical, paquipleuritis, complejo primario), baciloscopías de expectoración (examen de elección, pedir 3-4, sensibilidad 80%) y cultivo de Koch (complementario, demora 2-4 semanas). Las baciloscopías deben tener más de 50 neutrófilos por campo para ser válidas. El tratamiento tiene dos fases: fase diaria (50 dosis de 4 fármacos RIPE: rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol) y fase trisemanal (48 dosis de 2 fármacos: rifampicina, isoniazida). Control con baciloscopía mensual. Si hepatitis: suspender todo y derivar (primero sacar pirazinamida). Si resistencia: tratamiento secundario por especialista. Casos especiales: fracaso (cultivo positivo desde el 4to mes, causa es resistencia, derivar a tratamiento secundario), recaída (caso nuevo post-tratamiento completo, tratamiento primario + estudio de contactos), abandono (suspensión por 1 mes o más, reiniciar tratamiento primario completo). Manejo de contactos: pedir clínica, radiografía y baciloscopía a todos los que viven con un bacilífero, más PPD en menores de 15 años. Si baciloscopía positiva o menor de 15 con radiografía alterada: tratamiento completo. Profilaxis con isoniazida 6 meses si PPD>10mm (o >5mm en VIH). Menores de 15 años siempre reciben isoniazida (3 o 6 meses según PPD). Recién nacido de madre tuberculosa: mantener lactancia, mascarilla a la madre, isoniazida al niño, BCG diferida.